

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ



*Κεφάλαιο αφιερωμένο, με αγάπη και σεβασμό, στους ασθενείς
που πολέμησαν με γενναιότητα και αξιοπρέπεια τον καρκίνο
και μας επέτρεψαν να τους κρατήσουμε το χέρι
μπαίνοντας στη βάρκα για τον Αχέροντα...*

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΥΣΕΩΣ ΟΓΚΟΥ

Γενικά: Το σύνδρομο λύσεως του όγκου (ΣΛΟ) είναι μια σοβαρή επιπλοκή, που εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και σπανιότερα σε συμπαγή νεοπλάσματα. Είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης ενδοκυττάρων ιόντων και μεταβολιτών από τα κακοήγη κύτταρα, συνήθως μετά την έναρξη της χημειοθεραπείας (δευτεροπαθές ΣΛΟ), αλλά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και πριν την έναρξη της ΧΜΘ ως αποτέλεσμα του υψηλού φορτίου της νεοπλασματικής νόσου. Το ΣΛΟ συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς που πάσχουν από μη Hodgkin λέμφωμα (NHL) και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), κατά τη χορήγηση συνδυασμένης κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας. Επίσης, σε οξεία και χρόνια Μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ/ΧΜΛ), πολλαπλό μυέλωμα, μυελοϊνωση, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, αμυλοείδωση, αλλά και σε καρκίνο μαστού, πνεύμονα, σεμίνωμα, μελάνωμα, κ.ά. Στην Παιδο-ογκολογία, αφορά σε περιπτώσεις NHL, ΟΛΛ, Β-ΟΛΛ και σε λέμφωμα Burkitt.

Αιτία: Κεντρικό ρόλο στην εμφάνιση ΣΛΟ έχει η ταχεία συσσώρευση ουρικού οξέος (UA) που προέρχεται από την αθρόα απελευθέρωση νουκλεϊκών οξέων, η οποία οδηγεί σε ΑΚΙ με διάφορους μηχανισμούς. Η ΑΚΙ, εν συνεχεία, περιορίζει τη νεφρική κάθαρση του καλίου, του φωσφόρου και του ουρικού οξέος, που οδηγούν σε υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία και δευτερογενή υπασβεσταιμία, οι οποίες – χωρίς θεραπεία – μπορεί να αποβούν θανατηφόρες.

Κλινική εικόνα: Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση – έως και 72 ώρες μετά από τη ΧΜΘ – αδυναμίας-κόπωσης, ναυτίας, εμέτων, κοιλιακού πόνου, κνησμού, λόξυγκα, ηλεκτρολυτικών διαταραχών (*υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία, υπερουριχαιμία και υπασβεσταιμία*), οι οποίες – εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά – μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή δυσλειτουργία και αρρυθμίες, οξεία νεφρική βλάβη (Acute Kidney Injury - AKI) με νεφρική ανεπάρκεια, δυσουρία, ολιγουρία, μεταβολική οξέωση, επιληπτικές κρίσεις, κόμα, θάνατο.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (*BP, HR, RR, SpO₂, T°C*) και διενεργούμε άμεσα ΗΚΓ. Εν ανάγκη εφαρμόζεται συνεχές ECG-monitoring και παρακολουθούμε τα ζωτικά σημεία του ασθενή, καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασής μας και της διακομιδής.
2. Λαμβάνουμε γενική αίματος και β/χ έλεγχο [*Glu, Urea, Creat, UA, AST/ALT, γ-GT, LDH, CRP, ηλεκτρολύτες (Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺)*], που είναι αναγκαία στη θεραπευτική αντιμετώπιση.
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή μεγάλου εύρους (#16-18G) και στα δύο άνω άκρα.
4. Για πρόληψη του ΣΛΟ, χορηγούνται βραδέως ενδοφλεβίως 4-5 lt / 24 h κρυσταλλοειδών διαλυμάτων που δεν περιέχουν κάλιο (ήτοι: NaCl 0,9% ή ορός NaCl 0,45% - D/W 2,5%) 24-48 ώρες πριν την έναρξη της ΧΜΘ και συνεχίζονται 48-72 ώρες μετά το πέρας της, για την επίτευξη επιθυμητού ρυθμού διούρησης $D > 2 \text{ ml/kg/h}$ ή αλλιώς 80-100 ml/m²/h.
5. Επί αναπτύξεως ΣΛΟ, στόχος είναι η αποκατάσταση φυσιολογικών συγκεντρώσεων των εξωκυττάρων διαλυμένων ουσιών. Εφόσον δεν υπάρχει πλήρης απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, η αποκατάσταση του όγκου υγρών – με στόχο την αύξηση της απέκκρισης των διαλυμένων ουσιών στους νεφρούς – αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της θεραπείας του ΣΛΟ. Παράλληλα, οι σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές (*υπερκαλιαιμία και υπασβεσταιμία*) αντιμετωπίζεται άμεσα και δεόντως, λόγω δυνητικών καρδιακών αρρυθμιών. Χορήγηση Φουροσεμίδης (5-10 amp. Lasix εντός 500 ml N/S σε 24h) βοηθά για επαρκή διούρηση.
6. Για τη μείωση του Ουρικού οξέος, σε ασθενείς με χαμηλό ή ενδιάμεσο κίνδυνο για ΣΛΟ χορηγείται Αλλοπουρινόλη (*Soluric*) (δόση: 100-800 mg / 24h) σε 2-3 διηρημένες δόσεις. Εναλλακτικά, χορηγείται Φεμπουξοστάτη (*Adenuric*) 80-120 mg / 24h. Η Ρασμπουρικάση (*Fasturtec*) 0,15-0,2 mg/kg/day (ήτοι: 1-2 amp. 7,5 ml/vial ή 7-13 amp. 1,5 ml/vial), δίνεται επί διαγνωσμένου ΣΛΟ, επί έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας, επί μη απάντησης στην Αλλοπουρινόλη κι επί ουρικού οξέος > 9 mg/dl. Η αλκαλοποίηση των ούρων αποφεύγεται.